

FISIOLOGIA	DIAGNÓSTICO	METAS	TRATAR SEGURO
Vaso rígido ↑ colágeno/↓ elastina/cálcio → ↑ VOP, ↑ pós-carga	Medir bem repouso, manguito certo, 2+ medidas, 2 braços; MAPA/MRPA	Hígido <80a <140/90 (<130 se bem tolerado), gradual	1ª linha tiazídico/símile · BCC (anlodipino) · IECA/BRA
↑ PAS, ↓ PAD perde recuo elástico → pressão de pulso larga = HSI	Deitado E em pé rastrear ortostática (↓ 20 PAS/↓ 10 PAD em 3 min)	≥80 anos tratar se PAS≥160 (HYVET); ~<140-150; cuidado se frágil	Combinar IECA/BRA+BCC ou +tiazídico; dose baixa > dose alta
Coração/condução HVE → disfunção diastólica (HFpEF); FA; ↓ reserva de FC	Armadilhas pseudo-HAS (Osler), avental branco, mascarada	Frágil mais branda, “a mais baixa tolerável”; evitar quedas	Evitar α-bloq (doxazosina), ação central, AINE; β não é 1ª linha
Autônômico/rim ↓ barorreflexo→ortostase; ↓ β→depende de volume; sódio-sensível	Limiar ≥140/90 (DBH 2020); AHA/ACC 2025 alvo <130/80	Evidência HYVET/SPRINT/STEP: benefício real, mas excluíram frágeis	Curva J / desprescrever não derrubar PAD; rever se quedas/PA cai com fragilidade

A RÉGUA — “IDOSO”

Individualizar a meta · Diagnóstico correto (MAPA/pseudo-HAS) · Ortostática (deitado e em pé) · Start low, go slow · Observar fragilidade e desprescrever (curva J, quedas).

ALERTAS

- **PP larga** = rigidez/risco; trate a HSI.
- **Medir em pé**: 1 queda já muda a meta.
- **Frágil**: não extrapole alvo intensivo; pense desprescrição.